

Répertoire des examens fédéraux de médecine 2020

20/12/2019

1) Socio-culturel (GME 8,27; GPR 2; GO 7.3)

Un enfant de 3 ans est amené par ses parents aux urgences avec de la fièvre et une raideur de nuque. Vous suspectez fortement une méningite. Lorsque vous proposez aux parents de procéder à une PL et de débuter une Abtt, ils refusent et vous disent: « Nous préférons le ramener à la maison et demander à un guérisseur de le prendre en charge». Comment réagissez-vous?

-  a. Vous contactez le médecin cantonal, qui peut vous autoriser à prendre les mesures médicales qui vous semblent justifiées.
-  b. Vous devez faire venir le guérisseur au chevet de l'enfant avant de pouvoir débuter sa prise en charge.
-  c. Vous traitez l'enfant sans devoir éclairer le contexte social et culturel de la famille.
-  a. Vous suivez la volonté des parents car ils ont le droit de prendre des décisions pour leur enfant.

1) Socio-culturel (GME 8,27; GPR 2; GO 7.3)

Un enfant de 3 ans est amené par ses parents aux urgences avec de la fièvre et une raideur de nuque. Vous suspectez fortement une méningite. Lorsque vous proposez aux parents de procéder à une ponction lombaire et de débuter une antibiothérapie, ils refusent et vous disent: « Nous préférons le ramener à la maison et demander à un guérisseur de le prendre en charge ». Comment réagissez-vous?

-  a. Vous contactez le médecin cantonal, qui peut vous autoriser à prendre les mesures médicales qui vous semblent justifiées.
-  b. Vous devez faire venir le guérisseur au chevet de l'enfant avant de pouvoir débuter sa prise en charge.
-  c. Vous traitez l'enfant sans devoir éclairer le contexte social et culturel de la famille.
-  a. Vous suivez la volonté des parents car ils ont le droit de prendre des décisions pour leur enfant.

Commentaire: Le droit parental de prendre de décisions pour leur enfant a des limites, surtout si le bien-être de l'enfant est mis en danger.

Dans de tels cas, l'autorité parental pour une décisions précise peut être enlevé temporairement.

2) Consentement (GME 29; GO 1.12)

Une femme de 64 ans souffrant d'une insuffisance rénale (en dialyse) est hospitalisée pour un œdème des poumons. L'équipe souhaite commencer la dialyse. La patiente accepte le principe. Cependant en début d'après-midi, au moment de brancher l'appareil, elle refuse, alors qu'elle est désorientée et semble confuse. Elle dit finalement qu'elle ne le souhaite pas. La question est posée à nouveau deux heures plus tard, alors qu'elle est plus lucide. Ne se souvenant pas de ce qu'elle a dit avant, la patiente accepte sans problème. Peut-on considérer que la patiente est capable de discernement et consentante?

-  a. Si la patiente est informée de l'indication, des bénéfices, risques et alternatives de la dialyse, son consentement est éclairé et valide.
-  b. La patiente a consenti. Par conséquent, il ne faut pas mettre en question la capacité de discernement.
-  c. La capacité de discernement est mise en doute. Il est prudent de l'évaluer en investiguant la compréhension de la situation, l'appréciation des conséquences et l'expression d'un choix volontaire.
-  d. Si la patiente n'a pas sa capacité de discernement, le médecin est en droit de décider pour elle.

2) Consentement (GME 29; GO 1.12)

Une femme de 64 ans souffrant d'une insuffisance rénale (en dialyse) est hospitalisée pour un œdème des poumons. L'équipe souhaite commencer la dialyse. La patiente accepte le principe. Cependant en début d'après-midi, au moment de brancher l'appareil, elle refuse, alors qu'elle est désorientée et semble confuse. Elle dit finalement qu'elle ne le souhaite pas. La question est posée à nouveau deux heures plus tard, alors qu'elle est plus lucide. Ne se souvenant pas de ce qu'elle a dit avant, la patiente accepte sans problème. Peut-on considérer que la patiente est capable de discernement et consentante?

-  a. Si la patiente est informée de l'indication, des bénéfices, risques et alternatives de la dialyse, son consentement est éclairé et valide.
-  b. La patiente a consenti. Par conséquent, il ne faut pas mettre en question la capacité de discernement.
-  **c. La capacité de discernement est mise en doute. Il est prudent de l'évaluer en investiguant la compréhension de la situation, l'appréciation des conséquences et l'expression d'un choix volontaire.**
-  d. Si la patiente n'a pas sa capacité de discernement, le médecin est en droit de décider pour elle.

Commentaire: Les bases d'un consentement éclairé sont la capacité de discernement, l'information et la volonté libre. La capacité de discernement peut aussi être réduite si le patient a consenti.

Si un patient n'a pas sa capacité de discernement par rapport à une décision, il faut qu'un représentant thérapeutique prend cette décision basée sur la volonté présumée du patient.

3) Confidentialité (GME 32; GPR 5; GO 7.3)

Votre patient de 36 ans vient d'apprendre qu'il est VIH positif. Il vous demande de ne pas informer son épouse enceinte du résultat (elle est également votre patiente), et vous dit qu'il ne souhaite pas lui en parler par ailleurs. Que dites-vous à votre patient?

-  a. Vous l'encouragez à en parler à son épouse de lui-même en lui donnant du temps à cet effet, si nécessaire.
-  b. Vous dites au patient que sa femme est dorénavant sérieusement à risque d'être infectée par le VIH et que c'est son devoir de l'informer du risque qu'elle court.
-  c. Vous dites au patient que la Loi sur la Santé Publique exige que vous rapportiez aux autorités tous les cas de VIH diagnostiqué (de manière anonyme), y compris le sien.
-  d. Tout ce que vous venez de dire ci-dessus

3) Confidentialité (GME 32; GPR 5; GO 7.3)

Votre patient de 36 ans vient d'apprendre qu'il est VIH positif. Il vous demande de ne pas informer son épouse enceinte du résultat (elle est également votre patiente), et vous dit qu'il ne souhaite pas lui en parler par ailleurs. Que dites-vous à votre patient?

-  a. Vous l'encouragez à en parler à son épouse de lui-même en lui donnant du temps à cet effet, si nécessaire.
-  b. Vous dites au patient que sa femme est dorénavant sérieusement à risque d'être infectée par le VIH et que c'est son devoir de l'informer du risque qu'elle court.
-  c. Vous dites au patient que la Loi sur la Santé Publique exige que vous rapportiez aux autorités tous les cas de VIH diagnostiqué (de manière anonyme), y compris le sien.
-  d. **Tout ce que vous venez de dire ci-dessus**

Il y a un fort risque pour la femme (et pour le bébé) d'être infectée. En plus il y a aujourd'hui des mesures de traitement et de prévention d'une transmission périnatale. Ainsi, c'est important que la femme soit informée. Mais comme le médecin est tenu au secret médical, c'est le patient qui devrait informer sa femme ou donner son accord que le médecin informe la femme. Un médecin peut être délié du secret médical a) par le patient, b) par une loi, c) par une autorité de l'état, p.ex. le médecin cantonal, basée sur une pesée d'intérêts.

4) Directives anticipées (GME 33; EPA 7.6, 7.16)

Un patient de 80 ans souffrant d'un emphysème, se présente aux urgences avec un très bon état de conscience, il se plaint de dyspnée. Une évaluation rapide fait fortement suspecter une pneumonie. Son état s'aggrave au risque de passer en insuffisance respiratoire, son état de conscience n'est cependant pas altéré. Des directives anticipées (DA), signées, trouvées dans son sac, indiquent qu'il souhaite bénéficier uniquement de « traitements non invasif » et que ces derniers ne devraient pas « prolonger inutilement sa vie ». Il n'a pas de représentant thérapeutique. Est-il justifié d'instaurer une ventilation mécanique (VM)?

-  a. Tant qu'il n'y a pas de représentant thérapeutique, les DA ne sont pas applicables.
-  b. Si le patient est alerte et en pleine possession de sa capacité de discernement, ses DA ne sont pas pertinentes pour la prise de décision.
-  c. Il n'est pas nécessaire d'informer le patient des risques et des avantages de la VM étant donné qu'il a des DA.
-  d. Il faut suivre les DA et établir un projet de soins de confort.

4) Directives anticipées (GME 33; EPA 7.6, 7.16)

Un patient de 80 ans souffrant d'un emphysème, se présente aux urgences avec un très bon état de conscience, il se plaint de dyspnée. Une évaluation rapide fait fortement suspecter une pneumonie. Son état s'aggrave au risque de passer en insuffisance respiratoire, son état de conscience n'est cependant pas altéré. Des directives anticipées (DA), signées, trouvées dans son sac, indiquent qu'il souhaite bénéficier uniquement de « traitements non invasif » et que ces derniers ne devraient pas « prolonger inutilement sa vie ». Il n'a pas de représentant thérapeutique. Est-il justifié d'instaurer une ventilation mécanique (VM)?

-  a. Tant qu'il n'y a pas de représentant thérapeutique, les DA ne sont pas applicables.
-  b. **Si le patient est alerte et en pleine possession de sa capacité de discernement, ses DA ne sont pas pertinentes pour la prise de décision.**
-  c. Il n'est pas nécessaire d'informer le patient des risques et des avantages de la VM étant donné qu'il a des DA.
-  d. Il faut suivre les DA et établir un projet de soins de confort.

Les directives anticipées ne sont applicables que dans une situation d'incapacité de discernement du patient ce qui ne semble pas le cas ici. Alors il faut bien informer le patient de l'indication médicale, des avantages et des risques du traitement proposé pour qu'il puisse donner son consentement éclairé (ou pas).

Dans une situation d'incapacité de discernement les directives anticipées doivent être interprétées et appliquées à la situation. Pour cela il n'est pas légalement nécessaire d'instaurer un représentant thérapeutique, mais ce dernier peut bien sûr aider à appliquer les DA.

5) Ethique et droit (GPR 13-14; GO 1.21)

Une patiente de 72 ans est admise aux SI pour troubles neurologiques sévères suite une hémorragie cérébrale, nécessitant une assistance respiratoire. Un an auparavant, elle avait rédigé des DA et désigné son mari comme représentant thérapeutique. Les DA spécifiaient que la p. ne souhaitait pas d'assistance respiratoire, ni d'autres moyens de maintien artificiel des fonctions vitales en cas d'état végétatif persistant (EVP) ou toute autre situation terminale. Lors de la discussion des DA avec l'époux, ce dernier précise que les DA n'étaient pas prévues pour une situation comme celle-ci (il ne considère pas que son épouse soit dans un EVP). Malgré un temps de réflexion le mari refuse l'arrêt de la ventilation. Devez-vous suivre les DA ?

- ☐ a. Oui, car le principe du respect de l'autonomie prime sur les autres principes de l'éthique biomédicale.
- ☐ b. Non, car le mari est le représentant thérapeutique et selon la loi de la protection de l'adulte il a le droit de décider selon ses propres valeurs.
- ☐ c. Selon la directive de l'Académie Suisse des Sciences Médicales, il faut utiliser les moyens de soutien éthique clinique et, en cas de conflit persistant, appeler la justice de paix.
- ☐ d. Il faut appeler la consultation éthique qui décide si le traitement est arrêté ou pas.

5) Ethique et droit (GPR 13-14; GO 1.21)

Une patiente de 72 ans est admise aux SI pour troubles neurologiques sévères suite une hémorragie cérébrale, nécessitant une assistance respiratoire. Un an auparavant, elle avait rédigé des DA et désigné son mari comme représentant thérapeutique. Les DA spécifiaient que la patiente ne souhaitait pas d'assistance respiratoire, ni d'autres moyens de maintien artificiel des fonctions vitales en cas d'état végétatif persistant (EVP) ou toute autre situation terminale. Lors de la discussion des DA avec l'époux, ce dernier précise que les DA n'étaient pas prévues pour une situation comme celle-ci (il ne considère pas que son épouse soit dans un EVP). Malgré un temps de réflexion le mari refuse l'arrêt de la ventilation. Devez-vous suivre les DA ?

- ☐ a. Oui, car le principe du respect de l'autonomie prime sur les autres principes de l'éthique biomédicale.
- ☐ b. Non, car le mari est le représentant thérapeutique et selon la loi de la protection de l'adulte il a le droit de décider selon ses propres valeurs.
- ☒ c. **Selon la directive de l'Académie Suisse des Sciences Médicales, il faut utiliser les moyens de soutien éthique clinique et, en cas de conflit persistant, appeler la justice de paix.**
- ☐ d. Il faut appeler la consultation éthique qui décide si le traitement est arrêté ou pas.

Les 4 principes d'éthique biomédicale de Beauchamp et Childress sont généralement au même niveau.

Dans une situation comme celle-ci il faut utiliser tous les moyens à trouver un accord et identifier la volonté présumée correcte de la patiente.

La consultation éthique est une aide dans cette démarche, mais son avis est purement consultatif.

Le représentant thérapeutique ne doit pas décider selon ses propres valeurs mais celles de la patiente.

6) Fin de vie (GPR 18,23; EPA 7.16)

Mr. Steven est un patient de 70 ans présentant un BPCO terminal, admis il y a un mois pour pneumonie. L'évolution a été compliquée par une insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique. Plusieurs tentatives de sevrage se sont révélées inefficaces. Bien éveillé et alerte, il communique par écrit par le biais de notes indiquant qu'il souhaite que le ventilateur soit stoppé. Vous est-il possible d'honorer sa demande?

- ☐ a. Oui, si sa capacité de discernement est intacte.
- ☐ b. Non, parce que l'arrêt de la ventilation mécanique tuerait le patient et ce serait une euthanasie interdite par article 114 du Code pénal suisse.
- ☐ c. Son représentant thérapeutique devrait prendre la décision.
- ☐ d. Seul le juge de paix peut ordonner la décision d'arrêter le ventilateur, car les conséquences de cet acte conduiront certainement à la mort.

6) Fin de vie (GPR 18,23; EPA 7.16)

Mr. Steven est un patient de 70 ans présentant un BPCO terminal, admis il y a un mois pour pneumonie. L'évolution a été compliquée par une insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique. Plusieurs tentatives de sevrage se sont révélées inefficaces. Bien éveillé et alerte, il communique par écrit par le biais de notes indiquant qu'il souhaite que le ventilateur soit stoppé. Vous est-il possible d'honorer sa demande?

- ☒ a. Oui, si sa capacité de discernement est intacte.
- ☐ b. Non, parce que l'arrêt de la ventilation mécanique tuerait le patient et ce serait une euthanasie interdite par article 114 du Code pénal suisse.
- ☐ c. Son représentant thérapeutique devrait prendre la décision.
- ☐ d. Seul le juge de paix peut ordonner la décision d'arrêter le ventilateur, car les conséquences de cet acte conduiront certainement à la mort.

Un patient en possession de la capacité de discernement peut décider de refuser tout traitement, y compris un traitement qui est vital. Il s'agit d'un retrait thérapeutique qui est légal dans cette situation.

7) Ethique de la recherche (GPR 22; GO 6.2)

Après avoir terminé une recherche portant sur des collections de tissus humains issus de la Biobanque locale, vous souhaitez poursuivre en développant une recherche génétique sur les échantillons conservés. Les patient ont signé un consentement général lors de leur séjour. Comment devez-vous procéder au plan du consentement pour effectuer la nouvelle recherche en laboratoire ?

- ☐ a. Comme les données génétiques sont particulières il vous faut un nouveau consentement spécifique.
- ☐ b. Vous n'êtes pas tenu d'obtenir un consentement si vous faites une recherche avec des données irréversiblement anonymisées.
- ☐ c. Vous êtes tenu d'obtenir un consentement explicite auprès de tous patients qui ont déjà donné un consentement général si vous débutez une nouvelle recherche, quelle qu'elle soit.
- ☐ d. Vous n'êtes pas tenu d'obtenir un consentement explicite auprès des patients qui ont déjà donné un consentement général dans la mesure où vous n'utiliserez que les échantillons en laboratoire sans faire participer les patients à la recherche.

7) Ethique de la recherche (GPR 22; GO 6.2)

Après avoir terminé une recherche portant sur des collections de tissus humains issus de la Biobanque locale, vous souhaitez poursuivre en développant une recherche génétique sur les échantillons conservés. Les patients ont signé un consentement général lors de leur séjour. Comment devez-vous procéder au plan du consentement pour effectuer la nouvelle recherche en laboratoire ?

-  a. Comme les données génétiques sont particulières il vous faut un nouveau consentement spécifique.
-  b. Vous n'êtes pas tenu d'obtenir un consentement si vous faites une recherche avec des données irréversiblement anonymisées.
-  c. Vous êtes tenu d'obtenir un consentement explicite auprès de tous patients qui ont déjà donné un consentement général si vous débutez une nouvelle recherche, quelle qu'elle soit.
-  **d. Vous n'êtes pas tenu d'obtenir un consentement explicite auprès des patients qui ont déjà donné un consentement général dans la mesure où vous n'utiliserez que les échantillons en laboratoire sans faire participer les patients à la recherche.**

Le consentement général permet d'utiliser des échantillons, y compris génétiques, d'un patient pour des fins de recherche. Sans un tel consentement on ne doit pas faire de la recherche sur ce matériel, même de manière anonymisée.

8) Individu / société (GMA 5; GO 1.23,7.7)

Vous êtes médecin de famille et vous recevez un nouveau patient. Mr. Bonvin et père de deux enfants et travaille dans un établissement socio-éducatif. Vous découvrez qu'il n'est pas vacciné contre les rougeoles. Il s'avère être opposant aux vaccinations et il veut vivre „le plus naturellement possible“. Laquelle des phrases suivantes est correcte?

- ☐ a. Sur le plan éthique, il y a un conflit entre le principe de bienfaisance et les principes de non-malfaisance et du respect de l'autonomie.
- ☐ b. Le médecin de famille porte aussi une responsabilité par rapport à la santé publique et la santé des personnes qui ne sont pas ses patients.
- ☐ c. Une vaccination forcée pour des adultes est éthiquement difficile à justifier et la stratégie mieux fondée est d'améliorer l'information et d'instaurer des incitations (p.ex. interdiction de travailler dans un établissement reconnu d'intérêt public).
- ☐ d. Toutes les trois phrases ci-dessus sont correctes.

8) Individu / société (GMA 5; GO 1.23,7.7)

Vous êtes médecin de famille et vous recevez un nouveau patient. Mr. Bonvin et père de deux enfants et travaille dans un établissement socio-éducatif. Vous découvrez qu'il n'est pas vacciné contre les rougeoles. Il s'avère être opposant aux vaccinations et il veut vivre „le plus naturellement possible“. Laquelle des phrases suivantes est correcte?

- ☐ a. Sur le plan éthique, il y a un conflit entre le principe de bienfaisance et les principes de non-malfaisance et du respect de l'autonomie.
- ☐ b. Le médecin de famille porte aussi une responsabilité par rapport à la santé publique et la santé des personnes qui ne sont pas ses patients.
- ☐ c. Une vaccination forcée pour des adultes est éthiquement difficile à justifier et la stratégie mieux fondée est d'améliorer l'information et d'instaurer des incitations (p.ex. interdiction de travailler dans un établissement reconnu d'intérêt public).
- ☒ d. Toutes les trois phrases ci-dessus sont correctes.

D'un côté il faut respecter une décision autonome sur son propre corps et la piqûre est intervention avec quelques minimes risques, de l'autre côté la vaccination sera bénéfique pour cet homme ainsi que pour d'autres.

Un médecin a une responsabilité envers son patient, mais aussi envers la santé publique et la santé d'autres personnes.

Une vaccination strictement forcée est difficile à justifier et à appliquer à cause du conflit de valeur indiqué ci-dessus.

Littérature



+ www.samw.ch (ASSM)